

RELATÓRIO CLÍNICO ESTRUTURADO

Documento de Apoio à Investigação Diagnóstica

1. IDENTIFICAÇÃO DO CASO

Paciente: Idosa

Comorbidades:

- Diabetes Mellitus
- Hipertensão Arterial
- Histórico de câncer de mama

Hábitos: Ex-tabagista (cessou há > 15 anos)

Medicações a Verificar:

- Anticoagulantes (Rivaroxabana, Apixabana, Varfarina)
- Antiagregantes (AAS, Clopidogrel)
- Anti-inflamatórios e outros de uso contínuo

2. QUEIXA PRINCIPAL E HDA

Queixa: Episódios de eliminação de sangue pela boca ("cuspir sangue").

História da Doença Atual (HDA):

- **Frequência:** Dois episódios de sangue vivo (vermelho).
- **Característica:** "Raios/fios de sangue" com intervalo de ~1 mês entre episódios.
- **Sintomas Associados:** Tosse crônica (anos) e tosse noturna.
- **Achado Relevante:** Pressão arterial baixa registrada em dois atendimentos.

3. HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS

Hipótese Sindrômica: Hemoptise NÃO maciça recorrente.

1. **Doença Pulmonar Crônica:** Bronquite crônica / DPOC / Bronquiectasias.
2. **Neoplasia Pulmonar:** Risco por idade, ex-tabagismo e histórico de câncer de mama.
(Prioridade Investigativa)
3. **Infecções:** Tuberculose ou infecções subagudas.
4. **Causas Medicamentosas:** Distúrbios de coagulação por uso de fármacos.
5. **Pseudo-hemoptise:** Origem em boca, gengiva ou nariz.

4. EXAMES E CONDUTA

Exames Realizados: Ecocardiograma (Normal), Raio-X de tórax (Inconclusivo), Vesícula (Descartada).

Exames Solicitados: Raio-X (Frente/Perfil), Hemograma, Plaquetas, Coagulação (TP/INR, TTPa), Função Renal.

Medicação Prescrita: Possível Antifibrinolítico (Ácido Tranexâmico) para controle de sintomas.

5. INTERPRETAÇÃO E PRÓXIMOS PASSOS

Plano de Ação

- **Prioridade:** Confirmar lista de medicamentos e checar exames de sangue.
- **Exame Chave:** **Tomografia de Tórax com Contraste (ou Angiotomografia).**
- **Investigação Adicional:** Pesquisa de BAAR (Tuberculose) e possível Broncoscopia.

6. ALERTA CLÍNICO E SEGURANÇA

Sinais de Alerta (Emergência)

Procurar pronto atendimento imediato se houver:

- Aumento do volume de sangue
- Pressão arterial muito baixa
- Presença de coágulos
- Confusão mental
- Falta de ar / Dor no peito
- Vômito com sangue
- Desmaio ou tontura intensa
- Fezes escuras (melena)

Nota sobre Pressão Baixa: Deve ser investigada separadamente (desidratação, medicação, anemia ou arritmia), pois pequenos volumes de sangue não justificam hipotensão.

Este relatório é um documento estruturado para suporte clínico. A Tomografia de tórax é a etapa decisiva para o diagnóstico definitivo.